

RECURSO CÍVEL Nº 5061520-61.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JANAINA DA SILVA (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRIDO: MATHEUS DA SILVA SOBREIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. PARECER DO NAT. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, para julgar improcedente o fornecimento da insulina glargina, nos termos do parecer do NAT. Sem condenação nas verbas sucumbenciais, eis que, o Recorrente foi vencedor. Publique-se. Intime-se. Com o transito em julgado, de-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5061520-61.2024.4.02.5101

510015701266 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5061520-61.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JANAINA DA SILVA (REPRESENTANTE) (AUTOR)

RECORRIDO: MATHEUS DA SILVA SOBREIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença, *verbis*: (evento 56, DOC1)

"I - RELATÓRIO

MATHEUS DA SILVA SOBREIRA, pessoa natural qualificada e representada nos autos, propõe ação pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de tutela de urgência, em face da **UNIÃO FEDERAL**, do **ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e do **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, objetivando o fornecimento de bomba de insulina e de insulina glargina, para tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela União (ev. 33, cont.1), uma vez que a parte autora demonstra que não havia conseguido pela via administrativa o medicamento e aparelho aqui pleiteados.

Logo, constata-se a necessidade da medida.

Nos termos do art. 196 da CF/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Em verdade, configura-se direito de natureza fundamental, cabendo aos seus titulares a possibilidade de exigir que o Estado - entendido como a integralidade dos Entes federados - proveja todos os meios necessários ao gozo integral de saúde digna, aí compreendido o fornecimento de medicamentos, próteses, internações ou, ainda, intervenções cirúrgicas.

Nessa linha, veja-se que a vinculação da Administração Pública ao fornecimento de assistência integral à saúde decorre não apenas de interpretação do art. 196 da CF/88, mas, também, da leitura do art. 6º, inciso I, alínea "d", c/c art. 19-M, inciso I, da Lei nº 8.080/90, que estabelecem o seguinte:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:

I- dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravamento à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Em relação ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106), fixou a seguinte tese:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

In casu, conforme relatório médico emitido em 11/03/2024, pelo Dr. Bruno M. de A. Pessoa (CRM 52.0118879-8), do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o autor foi diagnosticado com **diabetes mellitus tipo 1** há 7 anos, apresentando, desde então, episódios de hipoglicemia severas e assintomáticas, que oscilam com hiperglicemias, aumentando o risco de complicações imediatas e sequelas em longo prazo (ev. 1, anexo3, fls. 17/18).

Pontua, ainda, que o quadro tem sido de difícil controle, com grande labilidade glicêmica, razão pela qual recomenda o uso do **sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina)**, visando a diminuir o risco de hipoglicemia.

No tocante à **insulina glargina**, o laudo registra que o paciente já fez uso das insulinas NPH e regular, fornecidas pelo SUS, porém não se mostraram eficazes para o controle desejado.

Sobre o quadro apresentado, especificamente acerca da insulina pleiteada, o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde exarou o seguinte parecer acerca dos medicamentos requeridos (ev. 47, parecer1, fls. 6/7):

8. As insulinas análogas de ação prolongada (grupo da insulina pleiteada glargina) foram incorporadas ao SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1, perfazendo o grupo de financiamento 1A do referido componente; medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados.

➤ Contudo, as insulinas análogas de ação prolongada ainda não integram, nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

9. Cabe ressaltar, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do diabetes mellitus tipo 1, publicado pelo Ministério da Saúde, é preconizado, dentre outros critérios, o uso da associação insulina de ação rápida + insulina NPH, por pelo menos 03 meses, antes de introduzir a insulina de ação prolongada. **No momento, o SUS disponibiliza, para tratamento do diabetes mellitus tipo 1, no âmbito da Atenção Básica, a insulina NPH em alternativa a insulina de ação longa (grupo da insulina pleiteada glargina - ainda não disponibilizada).**

10. Todavia, conforme documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 11) o Autor "...com grande variabilidade glicêmica em uso de insulina NPH e Regular, trocou pelo análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS e análogo de insulina basal glargina e manteve hipoglicemias graves assintomáticas, indicando o uso de bomba de insulina".

11. Neste contexto, cabe ressaltar que a insulina basal glargina pleiteada não se configura como opção terapêutica para manejo do quadro clínico do Autor, neste momento, uma vez que, para a utilização do sistema de infusão contínua de insulina, as insulinas de escolha são as insulinas análogas de ação rápida (lispro, asparte e glulisina).

12. Isto posto, informa-se que o Autor já utiliza o “análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS”, conforme consta em documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 11).

• Neste sentido, cabe ressaltar que o grupo das insulinas análogas de ação rápida foi incorporado ao SUS para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1, conforme os critérios de acesso definidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da referida doença.

✓ No momento, o Ministério da Saúde disponibiliza a insulina análoga de ação rápida. A dispensação é feita pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

✓ Em consulta realizada ao Sistema Nacional da Assistência Farmacêutica – Hórus, na presente data, verificou-se que o Autor está cadastrado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o recebimento da insulina análoga de ação rápida ofertada pelo SUS, com retirada autorizada para o período de 24/7/24 a 31/12/24.

No caso em análise, o médico assistente salienta que o paciente já fez uso de insulina NPH e regular, sem observar eficácia no controle dos sintomas da diabetes (ev. 1, anexo3, fl. 17), concluindo-se que a alternativa disponibilizada pelo SUS não configura opção terapêutica satisfatória.

Embora o NAT considere que a insulina glargina não seja opção terapêutica para o manejo do quadro clínico do autor, indicado, em substituição, as do tipo lispro, asparte e glulisina (que também não são ofertadas pelos Serviço de Saúde), no presente caso deve sobressair o parecer do médico assistente, profissional vinculado ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que acompanha de perto a evolução do paciente.

Dessa forma, a incerteza científica aduzida pelo núcleo de técnico, que é genérica e estatística, é eficazmente contrastada por laudo médico personalizado, específico às necessidades do paciente, prescrito por profissional que conhece o autor e tem melhores condições de avaliar a melhor alternativa terapêutica para o seu quadro clínico.

A presente análise é subjetiva e não vincula outros pedidos versando sobre o mesmo medicamento e doença, sempre dependendo de cotejo entre o parecer do NAT e a quantidade de evidência médica voltada ao caso concreto carreada caso a caso pela parte postulante.

Assim, tenho que o caso se enquadra nas situações excepcionais em que é possível a concessão do medicamento, porquanto demonstrada a necessidade e indicação para o quadro de saúde apresentado, bem como a inviabilidade das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS.

Relativamente à bomba de insulina, pondera-se que, quando da análise da medida de urgência, o órgão consultivo ainda não havia se manifestado, razão pela qual, levando-se em conta a imediatividade do pedido, este juízo se valeu de parecer apresentado em outro processo, num caso similar, decidindo pelo indeferimento do pleito.

Agora, já havendo parecer específico para o quadro clínico do autor, verificam-se condições próprias quanto à premência do equipamento. Vejamos (ev. 47, parecer1, 5/6):

1. Trata-se de Autor com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde a infância, apresentando grande variabilidade glicêmica, com hipoglicemias graves e assintomáticas. Solicita o fornecimento do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis e do medicamento insulina glargina

2. Atualmente, para a utilização da bomba de insulina, são consideradas indicações: a dificuldade para normalizar a glicemia, apesar de monitoramento intensivo e controle inadequado da glicemia, com grandes oscilações glicêmicas, ocorrência do fenômeno do alvorecer (dawn phenomenon), pacientes com hipoglicemias noturnas frequentes e intensas, indivíduos propensos a cetose, hipoglicemias assintomáticas, grandes variações da rotina diária e pacientes com dificuldade para manter esquemas de múltiplas aplicações ao dia.

3. Diante do exposto, **informa-se que o uso do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis está indicado ao manejo de quadro clínico do Autor** – diabetes mellitus tipo 1 desde a infância, com grande variabilidade glicêmica, com hipoglicemias graves e assintomáticas (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 a 20).

4. Elucida-se que, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) concluiu que as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia.

5. Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido.

6. Salienta-se que o uso da bomba de insulina e seus acessórios apesar de necessário para o tratamento do Autor, não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas aplicadas por via subcutânea durante o dia (esquema padronizado pelo SUS) ou sistema de infusão contínua de insulina (sistema não padronizado pelo SUS), sendo ambas eficazes no tratamento dos pacientes diabéticos.

• Entretanto, consta em documento médico (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 a 20) que o Autor "...com grande variabilidade glicêmica em uso de insulina NPH e Regular, trocou pelo análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS e análogo de insulina basal Glargina e manteve hipoglicemias graves assintomáticas". Portanto, entende-se que o uso do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis, se configura como melhor opção terapêutica neste momento.

7. No que tange ao fornecimento do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis no âmbito do SUS, estes não se encontram padronizados em nenhuma lista oficial de equipamentos e insumos para dispensação no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro. Assim, não há atribuição exclusiva do município ou do Estado do Rio de Janeiro quanto ao seu fornecimento.

Assim, apesar de haver no SUS esquema padronizado para medir o índice glicêmico, o NAT atesta que, neste específico caso, as alternativas fornecidas pela Administração Pública não configura o melhor tratamento para a saúde do autor.

Ademais, é prudente considerar que o juiz relator da 8ª Turma Recursal, em sede de medida de urgência interposta pela parte autora contra a decisão do ev. 13, determinou aos réus o fornecimento da bomba de insulina (ev. 19 do recurso), já tendo os órgãos públicos adotados medidas para aquisição do equipamento, que é de elevado valor (ev. 30 do recurso).

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** para determinar que a parte ré forneça ao autor INSULINA GLARGINA e BOMBA DE INSULINA, na forma e quantidade indicadas pelo médico assistente (ev. 1, anexo3, fls. 16/20), devendo a entrega do medicamento ser condicionada à apresentação de relatório médico atualizado a cada 3 (três) meses, ante a necessidade de reavaliação periódica do quadro.

Direciono o cumprimento do julgado, em primeiro lugar, ao Estado do Rio de Janeiro, consoante já definido na decisão do ev. 13.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

P.R.I."

A União afirmou que e a parte autora não formulou qualquer pedido de fornecimento em via administrativa para que seja franqueado o acesso à jurisdição. Afirmou que existem alternativas terapêuticas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, a necessidade do direcionamento do cumprimento da obrigação para o Estado, a necessidade de ressarcimento da União Federal, da apreciação dos honorários por apreciação equitativa. Requereu a reforma da sentença, para a improcedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva e à solidariedade dos entes públicos federativos, *verbis*:

"Processo REsp 1203244 / SC RECURSO ESPECIAL 2010/0137528-8

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

Data do Julgamento 09/04/2014

Data da Publicação/Fonte DJe 17/06/2014 RIP vol. 87 p. 283

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTOS**. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de **medicamentos** ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE

607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA Seção do Superior Tribunal de Justiça: "A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram, oralmente, os Drs. SÉRGIO LAGUNA PEREIRA, pelo recorrente, e DANIELLE ALEIXO REIS DO VALLE SOUZA, pela União.

Notas

Julgado conforme procedimento previsto para os **Recursos Repetitivos** no âmbito do STJ. Veja os **EDcl no RESp 1203244-SC** que foram acolhidos."

Assim, os cidadãos podem postular a concessão de medicamentos, insumos e, por analogia, procedimentos médicos de todos os órgãos federados.

A parte autora comprovou, por meio de laudo, que possui diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde a infância, com grande variabilidade glicêmica em uso de insulina NPH e Regular.

Foi realizada, corretamente, a intimação do Núcleo de Assistência Técnica, NAT, para emissão de parecer, nos termos do que dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "*Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)*"

O NAT juntou parecer no evento 47, PARECER1.

III – CONCLUSÃO

1. Trata-se de Autor com diagnóstico de **diabetes mellitus tipo 1** desde a infância, apresentando grande **variabilidade glicêmica**, com **hipoglicemias graves e assintomáticas**. Solicita o fornecimento do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus **acessórios e insumos descartáveis** e do **medicamento insulina glargina**.

2. Atualmente, **para a utilização da bomba de insulina**, são consideradas **indicações**: a dificuldade para normalizar a glicemia, apesar de monitoramento intensivo e controle inadequado da glicemia, com grandes oscilações glicêmicas, ocorrência do fenômeno do alvorecer (*dawn phenomenon*), pacientes com **hipoglicemias** noturnas frequentes e **intensas**, indivíduos propensos a cetose, **hipoglicemias assintomáticas**, grandes variações da rotina diária e pacientes com dificuldade para manter esquemas de múltiplas aplicações ao dia¹⁵.

3. Diante do exposto, informa-se que o uso do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus **acessórios e insumos descartáveis** **está indicado** ao manejo de quadro clínico do Autor – **diabetes mellitus tipo 1** desde a infância, com grande **variabilidade glicêmica**, com **hipoglicemias graves e assintomáticas** (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 a 20).

4. Elucida-se que, de acordo com o **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1**, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) concluiu que **as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia**¹⁶.

5. Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a **não incorporação no SUS** do **sistema de infusão contínua de insulina** (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com **diabetes tipo 1** que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido¹⁷.

6. Salienta-se que o uso da bomba de insulina e seus acessórios **apesar de necessário** para o tratamento do Autor, **não é imprescindível**. Isto decorre do fato, de **não se configurar item essencial** em seu tratamento, pois pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas **aplicadas por via subcutânea** durante o dia (**esquema padronizado pelo SUS**) ou **sistema de infusão contínua de insulina** (**sistema não padronizado pelo SUS**), sendo **ambas eficazes no tratamento dos pacientes diabéticos**¹⁸.

- Entretanto, consta em documento médico (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 a 20) que o Autor “...com grande **variabilidade glicêmica** em uso de insulina NPH e Regular, trocou pelo análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS e análogo de insulina basal **Glargina** e manteve **hipoglicemias graves assintomáticas**”. Portanto, entende-se que o uso do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus **acessórios e insumos descartáveis**, **se configura como melhor opção terapêutica neste momento**.

7. No que tange ao fornecimento do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus **acessórios e insumos descartáveis** no âmbito do SUS, estes **não se encontram padronizados** em nenhuma lista oficial de equipamentos e insumos para dispensação no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro. Assim, **não há atribuição exclusiva do município ou do Estado do Rio de Janeiro quanto ao seu fornecimento**.

8. As insulinas análogas de **ação prolongada** (grupo da insulina pleiteada **glargina**) **foram incorporadas ao SUS** no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento do **diabetes mellitus tipo 1**¹⁹, perfazendo o **grupo de financiamento 1A** do referido componente: **medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados**^{20,21}.

- Contudo, as **insulinas análogas de ação prolongada ainda não integram**²², nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

9. Cabe ressaltar, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)²³ do **diabetes mellitus tipo 1**, publicado pelo Ministério da Saúde, é preconizado, dentre

outros critérios, o uso da associação insulina de ação rápida + insulina NPH, por pelo menos 03 meses, **antes** de introduzir a insulina de ação prolongada. No momento, o SUS disponibiliza, para tratamento do diabetes mellitus tipo 1, no âmbito da Atenção Básica, a insulina NPH em alternativa a insulina de ação longa (grupo da insulina pleiteada **glargina** – ainda não disponibilizada).

10. Todavia, conforme documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 11) o Autor “...com grande **variabilidade glicêmica em uso de insulina NPH e Regular, trocou pelo análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS e análogo de insulina basal glargina e manteve hipoglicemias graves assintomáticas, indicando o uso de bomba de insulina**”.

11. Neste contexto, cabe ressaltar que a **insulina basal glargina pleiteada não se configura como opção terapêutica para manejo do quadro clínico do Autor**, neste momento, uma vez que, **para a utilização do sistema de infusão contínua de insulina, as insulinas de escolha são as insulinas análogas de ação rápida (lispro, asparte e glulisina)**²⁴.

12. Isto posto, informa-se que o Autor já utiliza o “**análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS**”, conforme consta em documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 11).

- Neste sentido, cabe ressaltar que o grupo das **insulinas análogas de ação rápida** foi **incorporado ao SUS** para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1, conforme os critérios de acesso definidos no **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)** para o tratamento da referida doença.

- ✓ **No momento**, o Ministério da Saúde disponibiliza a **insulina análoga de ação rápida**. A dispensação é feita pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

- ✓ Em consulta realizada ao Sistema Nacional da Assistência Farmacêutica – Hórus, na presente data, verificou-se que o Autor **está cadastrado** no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o recebimento da **insulina análoga de ação rápida ofertada pelo SUS**, com retirada autorizada para o período de 24/7/24 a 31/12/24.

13. No que concerne ao valor do medicamento pleiteado, para um medicamento ser comercializado no país, é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a autorização de **preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)**²⁵.

14. De acordo com publicação da CMED²⁶, o **Preço Fábrica (PF)** deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os

medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o **Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)** é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

15. Assim, considerando a regulamentação vigente, em consulta à Tabela de Preços CMED, verifica-se que a **insulina glargina 100U/mL (Glatius®)** solução injetável com 3mL, possui preço de fábrica R\$ 43,81 e preço máximo de venda ao governo R\$ 34,38, para o ICMS 20%²⁶.

16. Elucida-se que o medicamento pleiteado, assim como **equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G)**, seus acessórios e insumos descartáveis, **possuem registros ativos** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

É o parecer.

Em primeiro lugar, o parecer ressaltou que o Autor está cadastrado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), para retira de medicação.

O parecer informou que o uso do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis está indicado ao manejo de quadro clínico do Autor – diabetes mellitus tipo 1 desde a infância, com grande variabilidade glicêmica, com hipoglicemias graves e assintomáticas.

Todavia afirmou que que o uso da bomba de insulina e seus acessórios apesar de necessário para o tratamento do Autor, não é imprescindível. Mas, considerando o seu caso específico, ***“entende-se que o uso do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis, se configura como melhor opção terapêutica neste momento.”***

Afirmou que o quanto ao fornecimento do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis no âmbito do SUS, estes não se encontram padronizados em nenhuma lista oficial de equipamentos e insumos para dispensação no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro. Assim, **não há atribuição exclusiva do município ou do Estado do Rio de Janeiro quanto ao seu fornecimento.**

Assim, a parte autora comprovou, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que a assiste, da imprescindibilidade do medicamento. Ressalte-se, ainda, que a parte autora demonstrou a incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento prescrito e está representada pela DPU.

Com relação à insulina análoga de ação prolongada (grupo da insulina pleiteada glargina), esta foi incorporadas ao SUS. Todavia, o parecer informa que a mesma não é adequada ao quadro clínico que acomete a parte autora.

Colhe-se do parecer:

“ (...) insulina basal glargina pleiteada não se configura como opção terapêutica para manejo do quadro clínico do Autor, neste momento, uma vez que, para a utilização do sistema de infusão contínua de insulina, as insulinas de escolha são as insulinas análogas de ação rápida (lispro,

asparte e glulisina)"

Assim, o pleito quanto ao fornecimento desse medicamento, insulina glargina, deve ser indeferido.

O NAT é composto por uma equipe de especialistas em saúde pública e para a emissão do parecer foram utilizados e analisados os documentos juntados pela parte autora.

Voto por conhecer e prover parcialmente o recurso, para julgar improcedente o fornecimento da insulina glargina, nos termos do parecer do NAT. Sem condenação nas verbas sucumbenciais, eis que, o Recorrente foi vencedor. Publique-se. Intime-se. Com o transito em julgado, de-se baixa.

5061520-61.2024.4.02.5101

510015701265 .V30